



B型肝炎疫苗 (Hepatitis B)

B型肝炎疫苗 (Hepatitis B)



◎疾病簡介

B型肝炎是肝炎的一種，當肝臟受到病毒、細菌或寄生蟲之感染，或因酒精中毒、藥物或化學物質等之傷害，使肝組織內發生肝細胞變質、壞死、白血球浸潤等炎症反應，稱為肝炎，由B型肝炎病毒所引起的肝炎叫「B型肝炎」。

B型肝炎是經由含有B型肝炎病毒的血液或體液透過皮膚或黏膜進入體內而感染。其途徑包括：輸血、打針、血液透析、針灸、刺青、紋眉、穿耳洞及共用牙刷或刮鬍刀時、性行為的感染。帶原者的陰道分泌物、唾液及精液中可能帶有B型肝炎病毒，但平常不至因此造成感染，但病毒濃度高時則仍有可能引起感染。

◎嬰兒B型肝炎預防接種的重要性

肝硬化與肝癌為國人主要死亡原因之一，且與B型肝炎慢性帶原者有密切關係。臺灣地區為B型肝炎高感染地區，成人之帶原率達百分之20，年幼時期的感染易演變成慢性帶原者，按時完成預防接種能有效預防B型肝炎的感染。

◎何種情況下新生兒應接種B型肝炎免疫球蛋白 (HBIG)

- 母嬰間的垂直感染，是臺灣地區B型肝炎盛行的重要原因，40-50%的帶原者是經由此途徑傳染。為阻絕垂直傳染，我國自75年7月起全面實施嬰幼兒B型肝炎疫苗接種計畫，除全面為幼兒常規接種B肝疫苗，同

時提供母親為高傳染性B肝帶原(s抗原及e抗原陽性)之新生兒於出生24小時內儘速注射1劑HBIG。實施至今，為再提升阻絕B型肝炎垂直傳染成效，**108年7月1日起，HBIG實施對象擴及108年7月1日(含)以後出生且母親為B肝表面抗原(s抗原)陽性之新生兒。**

- 孕婦於妊娠第12週或第1次產檢時應進行B型肝炎表面抗原及e抗原檢查，檢驗結果若為B型肝炎表面抗原陽性者，其所生之嬰兒：
 1. 不論其出生體重亦或早產，如臨床狀況穩定，於**出生後應儘速注射1劑HBIG及B型肝炎疫苗，越早越好，不要晚於24小時**。前述嬰兒之出生體重如低於2,000公克，於其出生體重滿2,000公克或出生滿1個月後，仍需依時程接種3劑B型肝炎疫苗，而出生接種劑次不列入計算。
 2. 出生體重若小於600公克，其HBIG於出生後仍應儘速接種。至於其第1劑B肝疫苗，建議於臨床狀況穩定且其生命安全無疑慮後再行接種。
 3. 在滿12個月大時，應進行B型肝炎表面抗原（HBsAg）及B型肝炎表面抗體（anti-HBs）等檢測，以瞭解其預防接種成效與感染狀況，及早採取後續補接種與追蹤措施。

◎接種時程

- 第1劑：出生24小內儘速接種，愈早愈好。
- 第2劑：出生滿1個月。
- 第3劑：出生滿6個月。

◎接種禁忌

- 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。

◎注意事項

- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 母親非B型肝炎帶原者之低出生體重兒（<2,000公克），其第1劑B肝疫苗，於體重超過2,000公克或出生滿1個月後接種。

◎接種後可能發生的反應：一般少有特別反應。

連結

[B型肝炎高危險群幼兒追蹤檢查與追加接種作業計畫](#)

[B型肝炎免疫球蛋白擴增接種對象海報](#) [B型肝炎免疫球蛋白 Q&A](#)

[B型肝炎疫苗Q&A](#)

最後更新日期 2013/1/9
